

■ 모더레이터 지침서- 평상시 감염병 유행 상황 발생 (일반 학교용)

구분 (진행시간)	훈련생 제시 자료	모더레이터 훈련 진행 지침
구성인원 확인 및 개인 소개		✓ 간략한 자기 소개 및 담당 역할 소개만 이루어지도록 함 ✓ 학교 감염병 대응 주요 구성원들이 모두 참석했는지 확인 ✓ 훈련생들에게 개별로 제공된 workbook의 시나리오 단계별 내용을 함께 읽은 후 구성원별로 적절한 대응을 논의하도록 함. ✓ 본인의 역할이 아니어도 다른 구성원의 역할을 함께 고민하여 도출할 수 있도록 함 ✓ 논의 시 workbook 상의 담당자별 역할 공란을 채워가면서 활용하도록 함
시나리오 0단계 예방활동 (10분)	S시 소재 oo 초등학교는 평상 시 감염병 환자 발생에 대비하여 대응체계를 구축하고 예방 활동을 수행하고 있다. 학교 감염병 관리 조직을 발생감시팀, 예방관리팀, 학사관리팀, 행정지원팀으로 구성하여 감염병 발생에 대비하고 있다. 예방접종 관리를 위해 담임교사는 가정통신문을 통해 예방접종 여부 확인과 미접종 학생에게 접종을 안내하고 있다. 또한 방역활동으로 4월-9월은 2개월에 1회, 10월-3월은 3개월에 1회 교내 소독을 진행하고 있으며, 모든 학생들에게 손씻기와 기침예절 교육을 주기적으로 진행하고 있다.	✓ 학생감염병 관리 조직 상의 본인의 역할을 확인하고 예방단계에 수행하는 주요조치 사항들을 개별로 숙지하도록 함 <pre> graph TD Principal[학교장] --- Coop[협력기관] Principal --- Staff1[] Staff1 --- AsstPrincipal[교감] AsstPrincipal --- Staff2[] AsstPrincipal --- Monitoring[발생감시팀] AsstPrincipal --- Prevention[예방관리팀] AsstPrincipal --- Academic[학사관리팀] AsstPrincipal --- Admin[행정지원팀] Monitoring --- Staff3[] Monitoring --- Tasks1[] Prevention --- Staff4[] Prevention --- Tasks2[] Academic --- Staff5[] Academic --- Tasks3[] Admin --- Staff6[] Admin --- Tasks4[] </pre> 발생감시팀 ▷ 전자/ 유증상자 파악 ▷ 밀접 접촉자 파악 예방관리팀 ▷ 감염병 예방 활동 ▷ 전자/ 접촉자 관리 ▷ 유행 확산 방지 ▷ 역학조사 협조 학사관리팀 ▷ 수업 결손 대책 수립 ▷ 학교 내 (의심)환자 이동 ▷ 등교중지 학생의 출결 관리 ▷ 등교중지 학생의 생활지도 ▷ 학부모 대상 상황 전파 행정지원팀 ▷ 위생 시설 관리 ▷ 방역/소독 활동 ▷ 예산 지원 ▷ 행정지원

✓ 학교 감염병 예방·관리 계획

- 감염병의 위협으로부터 학생과 교직원을 보호하고 정상적인 학교 기능을 유지

- 1) 학생과 교직원의 감염병 이환(병에 걸림)을 예방
- 2) 학교 내 감염병을 조기 발견하고 사후 조치를 신속히 함으로써 유행 확산을 방지
- 3) 학교 내 감염병 유행 시 체계적으로 대응함으로써 학교 기능을 유지하고 지역사회 전파를 차단

✓ 학교 감염병 관리조직 구성

- 발생감시팀

- 1) 구성원 : 생활지도 담당 부장급 교사(총괄), 학년부장, 담임교사, 교과담당교사, 보건(담당)교사 등
- 2) 역할 : 감염병 (의심)환자의 신속한 파악 및 밀접접촉자 파악

- 예방관리팀

- 1) 구성원 : 보건(담당)교사(총괄), 담임교사 등
- 2) 역할 : 보건교육(위생수칙 등), (의심)환자/접촉자 관리, 유행확산 방지, 보건소 등 외부기관에서 역학조사 시 협조

- 학사관리팀

- 1) 구성원 : 교무부장(총괄), 교육과정부장, 담임교사 등
- 2) 역할 :
 - 수업 및 출결 관리
 - (의심)환자 이동이나 일시적 격리로 인한 교사 공백에 대한 조치(수업 조정, 교실 내 학생 관리)
 - 등교 중지 학생에 대한 행정 처리
 - 휴업/휴교나 등교 중지 시 학생들의 가정학습과 생활관리
 - 학부모 대상 상황 전파

- 행정지원팀

- 1) 구성원 : 행정실장(총괄), 행정실 직원 등
- 2) 역할 : 위생시설 관리, 방역/소독 활동, 예산 및 행정 지원

✓ 수두 예방접종 관리

- 예방접종 : 생후 12-15개월에 백신 1회 접종(만 13세 이상 미접종자는 4-8주 간격 2회 접종)

- 대상 : 모든 입학생

- 담임교사

- 1) 가정통신문 배부 : 입학생 예방접종 여부 확인 및 미접종 학생 접종 안내
- 2) 최종적으로 예방접종 내역이 나이스(NEIS)로 확인되지 않은 학생은 취학아동 예방접종증명서를 수거하여

보건(담당)교사에게 전달

- 보건(담당)교사 : 미접종 학생 대상 예방접종 현황 파악 및 보건소에 관련 자료 제출, 가정통신문(안) 작성

✓ 감염병 예방 교육 실시

- 담당 : 보건(담당)교사, 담임교사, 관련교과교사
- 내용
 - 1) 개인위생 철저(손 씻기, 마스크 착용, 기침예절 등)
 - 2) 수두 예방접종 홍보
- 방법 : 강의식 교육, 방송교육, 교육자료 게시, 관련 동영상 시청, 실습, 가정통신문, SNS 등

✓ 수동감시체계 운영

- 수동감시 : 평소에 학생들을 관찰하거나 보건실 이용 과정을 통해 감염병 (의심)환자를 발견하는 것
- 목적 : 감염병 (의심)환자를 조기에 발견하여 학교 내 감염병 발생단계 업무 흐름도에 따라 체계적 대응
- 담당
 - 1) 보건(담당교사) : 보건실 이용 학생 중 감염병 (의심)환자 발견 및 확인 후 담임교사에게 알림.
 - 2) 담임교사 : 담당 학급 학생에 대한 상시 관찰, 결석자 파악 등을 통해 감염병 (의심)환자를 발견하여 보건(담당)교사에게 알림.
 - 3) 교과담당교사 : 수업 중 감염병 (의심)환자를 발견한 경우 보건(담당)교사와 담임교사에게 알림.
 - 4) 방법 : 학생/학부모의 자발적 통지, 교사의 관찰, 보건실 이용 학생의 관찰 등을 통해 발견
 - 수두의 증상에 대해 「감염병 감시 대상 정보 제공 요령」을 참고하여 정보를 발생감시팀에게 제공
 - 담임교사는 학생 및 학부모를 대상으로 감염병 진단 또는 의심증상 발생 시 즉시 담임교사나 보건(담당)교사에게 알릴 수 있도록 교육함

✓ 방역활동

- 교내 소독 주기 : 4월-9월은 2개월에 1회 이상, 10월-3월은 3개월에 1회 이상
 - ※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별표7]」 제36조제4항 관련
- 고체 혹은 액체비누 등 손 세척 도구는 세면대 1대당 1개를 설치 권장
- 손말리기 도구는 화장실 1개 소당 1개를 설치하되, 쉬는시간 10분 안에 더 위생적이고 신속하게 손을 말릴 수 있는 1회용 종이타월을 권장(구입비용 등 어려움이 있는 경우 개인별 손수건 사용 권장)
- 적절한 수량 확보/유지
 - 1) 학생 수 및 학급 수 등 학교 규모를 고려하여 발열감시, 전파 차단, 소독을 위해 상시 비축 :
알코올 손 소독제(교실 4개, 보건실 8개), 고막 또는 비접촉식 체온계(교실 및 보건실 각각 1개), 의료용 장갑(교실 5개), 일회용 마스크(교실 20개, 보건실 학생 10명당 3개), 방역용(N95, KF94) 마스크(교실 5개, 보건실 20개) 등
 - 2) 방역 물품 소모시 추가 구매를 통해 필요 수량을 유지

		3) 방역물품을 구매하고 추가 구입 예산을 확보
시나리오 단계 1 유증상자 발생 (15분)	S시에 소재한 ○○초등학교는 한 학년이 세 개 반으로 6학년까지 있고, 한 개 반은 20명의 학생으로 구성되어 있다. 학교 건물은 한 개 동 4층 건물로 1층에는 교장실, 교무실, 보건실, 휴게실, 1학년 교실이 있고, 2층에는 2학년 교실과 강당, 도서관, 3층부터 4층까지는 3, 4, 5, 6학년 교실로 구성되어 있다. 3월 21일 ○○초등학교 2학년 3반 철수가 미열과 고통을 호소하였고, 담임교사가 상태를 살펴본 결과 두피와 얼굴에 몇 개의 반점을 확인하였다.	[담임교사] 1) 보건교사에게 유선으로 철수의 상태를 정확하게 전달 2) 교실을 환기시키고, 철수와 접촉한 학생들에게 손을 씻고, 마스크를 착용하도록 지시 3) 철수와 직접 동행하여 보건실로 이동(이동 시 약 2m 거리 유지, 담임교사가임신부 등 고위험군일 경우 교무부장에 연락하여 이동 담당교사 지정) 4) 보건교사의 판단에 따라 철수를 교내에 마련된 일시적 관찰실에 일시적으로 격리시킴, 교무부장에게 기타학생들에 대한 수업 진행 등 관리를 요청함 5) 철수의 부모님께 연락하여 근처 병원에서 진료를 볼 수 있도록 함
		[보건(담당)교사] 1) 담임교사와 철수가 보건실에 도착한 즉시 손을 씻도록 요청 2) 보건교사는 마스크 착용, 철수의 체온 체크 및 증상을 관찰한 후 감염병이 의심되는지 확인 3) 일시적 격리가 필요하므로 교무부장에게 연락하여 격리 담당 교사 결정 요청 4) 철수를 격리 담당 교사와 휴게실(일시적 관찰실)로 이동시킴. 부모님이 오실 때 까지 담당교사를 통해 철수의 상태를 주기적으로 보호관찰 5) 일시적 격리를 알리는 안내판 부착(혹은 방송) 등을 통해 전체 학생과 교직원에게 2학년 3반, 보건실, 휴게실 접근 금지를 알림
		[행정실] 2학년 3반, 보건실 및 철수의 귀가 후 휴게실(일시적 관찰실)의 환기 및 소독 ✓ 마스크 착용 필요 상황은? - 마스크 착용이 필요한 감염병을 진단받았거나 주증상이 기침, 두통, 발열, 발진, 인후통, 침샘비대에 포함하는 경우, 감염병(의심)환자와 이동 담당교사는 각 교실에 비치된 마스크를 착용 ✓ 환기나 소독이 필요한 상황은? ✓ 감염병(의심)환자 이동 수칙 확인 - 감염병 (의심)환자가 교내에서 혼자 이동하는 것을 원칙적으로 금지함.

조 치	감염병 의심증상	감염병(예시)
환기	기침, 발열, 발진, 침샘 비대, 인후통 등	결핵, 뇌수막염, 디프테리아, 메르스, 백일해, 수두, 수족구병, 유행성 이하선염, 인플루엔자, 조류인플루엔자 인체감염증, 중증급성호흡기 증후군, 풍진, 홍역 등
소독 (출입문, 책상, 의자 등)	구토, 기침, 발열, 발진, 설사, 인후통, 충혈, 침샘 비대, 등	결핵, 급성출혈성결막염, 노로바이러스, 뇌수막염, 디프테리아, 메르스, 백일해, 살모넬라균 감염증, 세균성 이질, 수두, 수족구병, 인플루엔자, 유행성각결막염, 유행성 이하선염, 장출혈성대장균 감염증, 장티푸스, 조류인플루엔자 인체감염증, 중증급성호흡기증후군, 콜레라, 파라티푸스, 풍진, 홍역, A형간염 등

1) 제시한 의심증상이나 감염병 이외에도 환기나 소독이 필요할 수 있음.

- 이동 시에는 담당교사가 동행하며 2m 정도의 거리를 유지함.
- 담당교사는 담임교사를 권장(만약 임신부 등 감염병 고위험군인 경우 다른 교사로 대체)
- 필요 시 마스크를 착용함.

✓ 수두 의심 증상은?

- 대부분 발진이 나타나며, 발진이 나타나기 전 미열, 권태감, 두통, 식욕부진 등이 나타남
- 전구기 : 발진이 나타나기 전에 경미한 전구 증상이 나타날 수 있음(소아는 대부분 발진이 첫 증상)
- 발진기
 - 1) 발진은 보통 두피, 얼굴, 또는 몸통에 먼저 나타나고 사지로 퍼지는 양상을 보임.
 - 2) 백신 미접종자는 발진이 전신화되고 가려움증이 있으며 반점(macules), 구진(papules), 수포(vesicles), 농포(pustules), 가피(crust) 순으로 병변이 24시간 이내 빠르게 진행됨
 - 3) 발진 병변(1-4mm)은 몸통에 가장 많이 나타나며, 기인두, 기도, 질, 결막, 각막 점막에도 생길 수 있음.
수포는 건조되고 딱딱해지기 전 터지거나 농포가 될 수 있음.
 - 4) 건강한 소아는 보통 2-4개의 연속된 부위에 250-500개의 병변이 나타나고, 증상 경미하여, 발진 시작 후 2-4일 이내 전신증상(발열, 권태감, 두통 등)이 호전됨.
 - 5) 면역이 떨어지는 소아는 중증 진행형 수두*로 발전할 수 있음
* 고열, 광범위한 수포 발진 및 합병증 발생률이 높은 것이 특징
 - 6) 회복기 : 모든 병변에 가피가 형성되면서 회복됨

✓ 일시적 격리가 필요한 상황은?

- 두통, 권태감, 식욕부진 등이 동반된 미열
- 미열이 동반된 발진
- 몸통, 두피 및 얼굴에 발진증상이 나타난 경우

		✓ 일시적 격리를 실시하고 관리하는 방안은? - 담당 : 학생의 심리적 안정을 위해 담임교사를 권고하되 학교 상황에 따라 자율적으로 결정함 (담임교사가 임신부 등 고위험군인 경우 다른 교직원이 담당). - 기간 : 보호자가 도착하여 의료기관 진료 받으러 가기 전까지 한시적으로 격리 - 장소 : 일시적 관찰실(다른 학생들의 접근이 드문 곳, 환기가 용이하며, 다수 환자 발생에 대비한 넓은 공간. 부득이한 경우 다른 침대와 2m의 간격을 유지하고 가림막(커튼, 파티션 등)으로 차단 실시(보건실은 제외) - 방법 : 담당교사가 같은 공간에서 학생과 2m 이상의 거리를 유지. 최대한 학생을 안정시킨 상태에서 주의 깊게 증상 변화를 관찰. 필요시 학생과 담당교사가 마스크를 착용 - 행정 조치 : 보건교사는 교무부장에게 연락하여 남은 학생들의 관리와 수업 조정을 요청. 출입구에 안내문을 부착하여 다른 사람들의 접근을 차단함. 사용시설은 관찰 해제 후 즉시 환기, 소독 실시
--	--	--

시나리오 단계 2 감염병 확진환자 발생 및 학교 내 감염병 유행 의심여부 확인 (20분)	3월 22일 2학년 3반 담임 교사는 결석한 철수의 부모님께게서, 철수가 수두로 확진 받고 개인병원에 입원하게 되었다는 사실을 통보 받았다.	[담임교사] 1) 철수에게 등교중지를 실시하는 것으로 하고 학부모에게 관련된 행정조치 안내 2) 수두에 대한 예방 교육을 실시함. 3) 철수의 반과 같은 층을 사용하는 2학년 담임교사 전체 공지 -> 능동감시 실시: 결석, 조퇴, 지각한 학생의 사유를 확인하고, 수두 의심증상 발생 여부를 조사함. 매일 1회 (의심)환자 발생 여부를 보건교사에게 통보함. 4) 전체 담임교사 -> 보호자에게 가정통신문을 배부하여 감염병 예방수칙의 준수와 의심 증상 발생 시 학교에 등교시키지 말고 의료기관 진료를 받도록 안내함. [보건(담당)교사] 1) 수두 환자 발생 사실을 학교장에게 보고하고, 나이스(NEIS)를 통해 교육지원청에 보고함. 2) 철수와 같은 반의 보건학적 고위험군의 포함여부를 확인 3) 능동감시 대상(철수와 같은 층을 사용하는 학급 전체) 파악 및 학교장 보고 4) 수두에 대한 예방 교육자료와 가정통신문을 기안하여 담임교사에게 배부를 요청함. [행정실] 2학년 3반과 같은 층에 모든 공간, 의심환자 발생 공간, 보건실 및 휴게실(일시적 관찰실)의 환기 및 소독 [교장 및 교감] 1) 관할 보건소와 연계를 통해 철수에 대한 신고여부를 확인하도록 함. 2) 생활부장에게 추가환자 파악 위한 능동감시 실시를 지시함 [생활부장] 능동감시 대상 학급 담임교사들에게 능동감시를 실시하고 그 결과를 보건교사에게 통보 요청 [교육청] 1) 철수의 학교 이외의 관내 다른 학교에서의 수두 발생 신고 여부 확인 2) 감염병 유행 시 필요한 행정조치에 대한 대비
---	---	--

[보건소]

- 1) 철수가 방문했던 의료기관의 법정감염병 신고 여부를 확인하고, 비슷한 시기 관내 다른 의료기관의 수두 신고 여부를 파악
- 2) 수두 유행 역학조사 대비
- 3) 학교에 필요한 예방 교육 자료 제공

✓ 학교 내 능동감시체계 운영방안은?

- 능동감시 : 유행의 발생이 의심되는 일정 기간 동안 문진, 검사 등의 방법을 이용하여 감염병(의심)환자를 적극적으로 파악하여 대응을 취하는 것
- 운영시기 : 의료기관 진료 결과 학교 내 감염병(의심)환자가 발견된 경우
- 운영방법 : 능동감시 범위는 보건(담당)교사가 결정
 - 1) 감염병 (의심)환자 1명 발생: 일부만 실시
 - 감염병(의심)환자가 발생한 학급이 있는 동일한 층의 학급
 - 이동식 수업 시 감염병(의심)환자와 함께 수업을 들은 학생들 전원
 - 2) 감염병 유행사례 : 3주 이내 (의사)환자가 학교 내 2명 이상 발생한 경우
- 감시방법 : 학생/학부모에 대한 설문, 신체검사(발열 측정 등) 등 적절한 방법으로 매일 1회 이상 파악

✓ 수두의 특성과 신고 및 보고 방안은?

- 잠복기 : 10-21일(평균 14-16일)
- 전염기간 : 발진이 나타나기 1-2일 전부터 모든 병변이 가피가 형성될 때까지
- 전파경로
 - 1) 환자의 수포액과 직접접촉(피부 병변이 주요 감염 전파원)
 - 2) 환자의 호흡기 분비물을 에어로졸로 흡입
 - 3) 급성 수두 또는 대상포진 환자의 피부병변 수포액을 에어로졸로 흡입
- 24시간 이내 환자 및 의사환자 보고

✓ 수두의 관리방안은?

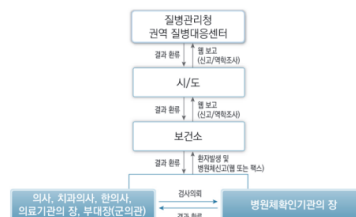
- 예방접종
 - 1) 소아 : 생후 12-15개월에 백신 1회 접종(만 13세 이상 미접종자는 4-8주 간격 2회 접종)
 - 2) 성인 : 4-8주 간격 2회 접종
- 노출 후 예방요법 : 수두 예방접종력이 없고, 과거에 수두를 앓은 적이 없는 사람이 수두(의사)환자에 노출된 경우
노출 후 가능한 3일 이내에 수두 백신 접종
- 보건교사 및 담임교사는 가정과 학교에서 노출가능성이 있는 사람들에게 증상감시 권고.

- 1) 노출자 중 이전에 수두 병력이 없었거나 예방접종을 하지 않은 어른(가족구성원, 교직원, 자원봉사자, 특히 임신했거나 면역저하자인 경우)의 경우 노출 사실을 알려야 하며, 의료기관에서 조치 권고
- 2) 질환의 특징 및 예방접종의 중요성에 관한 교육
- 3) 손위생 및 기침예절에 관한 교육
- 4) 타액 및 호흡기 분비물과 오염물 관리 요령에 관한 교육
- 5) 노출된 임신부는 노출 24시간 내에 의사 방문토록 함

✓ 학교장이 직접 보건소에 의무적으로 신고하여야 하는 법정 감염병은?

- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제1급감염병부터 제3급감염병까지에 해당하는 감염병 중 보건복지부령으로 정하는 감염병이 발생한 경우에는 의사, 치과의사 또는 한의사의 진단이나 검안을 요구하거나 해당 주소지를 관할하는 보건소장에게 신고하여야 한다.
 - 학교, 사회복지시설, 병원, 관공서, 회사, 공연장, 예배장소, 선박·항공기·열차 등 운송수단, 각종 사무소·사업소, 음식점, 숙박업소 또는 그 밖에 여러 사람이 모이는 장소로서 보건복지부령으로 정하는 장소의 관리인, 경영자 또는 대표자
 - ※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항제2호 관련
- 제12조제1항 각 호외의 부분 중에서 “보건복지부령으로 정하는 감염병”이란 다음 각 호의 감염병을 말한다.
 1. 결핵 2. 홍역 3. 콜레라 4. 장티푸스 5. 파라티푸스 6. 세균성이질 7. 장출혈성대장균감염증 8. A형간염
 - ※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제8조 관련
- 그 밖의 신고의무자는 다음 각 호의 사항을 서면, 구두(口頭), 전보, 전화 또는 컴퓨터통신의 방법으로 보건소장에게 지체없이 신고하거나 알려야 한다.
 1. 신고인의 성명, 주소와 감염병환자등 또는 사망자와의 관계
 2. 감염병환자등 또는 사망자의 성명, 주소 및 직업
 3. 감염병환자등 또는 사망자의 주요 증상 및 발병일
 - ※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제9조 관련

✓ 법정감염병 신고 및 보고 체계



시나리오 단계 3 감염병 유행상황 발생 (20분)	수두로 입원치료 중인 철수의 담임교사 및 ○○초등학교 선생님들은 보건교사의 요청에 따라 다른 학생들을 능동감시 한 결과, 3월 31일부터 4월 3일 사이에 같은 반 학생 7명에게도 수포가 발생하였음을 확인하였고, 2학년 3반과 같은 층, 같은 화장실을 쓰는 2학년 1반 2명, 2학년 2반 3명, 2학년 3반 5명 등 총 10명의 학생에게서 미열, 두통, 발진 증상이 있음을 확인하였다. ○○초등학교 교장은 학교 감염병 관리조직 팀을 점검하고 가동하도록 지시하였다.	[담임교사] 1) 나이스(NEIS)의 [보건/감염병 환자 관리] - [감염병 환자 등록]에 환자 발생을 등록 2) 본인의 반 학생들의 결석/조퇴/지각 사유 확인과 (의심)환자 파악 3) 매일 1교시 마치기 전까지 학년부장을 통해 보건교사에게 보고 4) 추가 발견된 수두(의심)환자 학생에 대하여 의료기관 진료를 의뢰하고 그 결과에 따라 등교중지 조치함. 5) 등교중지 학생에게 생활지도를 실시하고 필요한 행정조치를 학부모에게 안내 [보건(담당)교사] 1) 유행의심 상황 발생을 학교장과 교육(지원)청에 보고 2) 환자발생 현황을 학교장과 교육(지원)청에 보고 3) 매일 보건실 이용 학생의 감염병 증상 여부를 확인 4) 수두의 환자 발생 현황 분석: (의심)환자/완치자 등 일일 현황 집계 5) 미리 파악한 고위험군 명단을 활용하여, 고위험군이 노출되는 경우 담임교사를 통해 즉시 의료기관 진료를 받도록 요청함. 임신 중인 교직원들에게 수두 감염 시의 위험성을 고지하고 조심하도록 교육함 [행정실] 1) 보건실, 교실, 일시적 관찰실 등의 환기 및 소독 2) 소독제를 이용하여 오염 가능성이 높은 물체 표면을 닦음 ○ 책상, 의자, 교탁, 창틀, 사물함, 출입문 및 화장실 손잡이, 악기, 실험실 실험도구, 컴퓨터실 키보드, 마우스 3) 전체 시설 소독 [교장 및 교감] 1) 신고가 필요한 경우 관할 보건소장에게 신고 2) 학생감염병 관리조직 활성화시킴 3) 단축수업 및 자체 휴업 실시 필요성 검토 4) 수학여행, 교내 행사 등 단체 활동의 제한 여부를 검토 [교육청] 1) 관내 학교에 대한 능동감시 실시 2) 관내 학교에 대한 관할 보건소 역학조사 요청 및 실시 협조 3) 휴업 등 행정조치 시 필요사항 검토
---	---	---

4) 필요시 방역물품 지원 및 언론 대응 협조

[보건소]

1) 교육(지원)청 또는 시설 보건(담당)교사로부터 역학조사 요청이 있을 시, 집단(유행) 사례 여부 파악함

1) 집단시설 소속 수두 (의심)환자가 2명 이상 발생 시 역학조사 실시

3) 역학조사 결과를 시·도 및 질병관리청 감염병관리과에 보고

4) 역학조사 실시 대상이 아닌 경우, 학교와의 협조체계를 강화하며 감염병 (의심)환자 발생 보고를 지연/누락하지 않도록 독려함

5) 휴업에 대한 학교의 문의 시 협의 및 자문

✓ 감염병 유행기준 판단 주체는?

- 감염병의 유행 여부를 학교 자체적으로 판단하는 것보다 보건소 및 시도 역학조사관의 역학조사 결과에 따르는 것이 바람직함. 다만 학교에서는 선제적인 감염병 확산 방지를 위해 유행을 의심할 수 있는 상황인지 판단하고, 이에 해당하면 실제 유행 여부와 관계없이 대응 제3단계에 해당하는 활동들을 수행함.

✓ 보건학적 고위험군이란?

- 감염병 발생의 위험이 높거나 감염 발생 시 합병증, 사망의 위험이 상대적으로 높은 만성질환자나 면역저하자이거나 감염 시 태아에게 영향을 미칠 수 있는 임신부 등

구 분	질 환
폐질환	만성폐쇄성폐질환(만성기관지염, 폐기종), 기관지확장증, 진폐증, 기관지폐형성이상, 천식 등
만성심혈관질환	선천성심장질환, 부정맥, 만성심부전, 허혈성 심질환 등(※단순고혈압 제외)
당뇨	인슐린이나 경구 혈당강하제를 필요로 하는 당뇨병
신장질환	콩팥증후군, 만성신부전증, 신장이식환자 등
만성간질환	간경변증 등
악성종양	교직원: 갑상선암, 위암, 폐암, 유방암 등 학생: 림프종, 백혈병, 뇌종양, 신경모세포종, 횡문근육종, 골육종 등
면역저하자	무비장증, 비장기능이상, HIV 감염자, 조혈모세포이식, 방사선 치료, 자가면역질환자, 화학요법치료로 면역저하유발, 스테로이드 복용, 기타 면역억제 치료자
발달장애	척추이분증, 뇌성마비, 다운증후군
임신부	현재 임신 중이거나 임신의 가능성이 높은 여성
기타	인지장애, 척수손상, 경련장애, 기타 신경근육질환 등으로 인해 흡인 위험 있는자

✓ **보건학적 고위험군 관리방안은?**

(환자/접촉자 관리) 고위험군 학생이 감염이 의심되거나 감염병 (의심)환자와 접촉한 경우 즉시 의료기관에 진료 의뢰 (위험경고) 학교 내 감염병 유행 시 학생과 보호자에게 알려, 주치의와 상담하여 적절한 예방조치를 취하도록 함.
(격리) 학교 내 감염병 유행 시 감염예방을 위해 보호자와의 상의를 통해 원할 경우 등교중지 시킬 수 있음.
(임신 교직원 관리) 임신부에게 문제를 일으킬 수 있는 감염병 유행 시 임신 중인 교직원에게 알려야 하며, 일시적 격리 담당인 경우는 다른 교사로 대체함.

✓ **감염병 유행 상황에서 감염병 환자 등록 주체는?**

- 담임교사가 실시하는 것을 권장함(유행 확산 시 환자 수 증가로 인해 환자 등록과 보고가 지연될 수 있으므로 즉시성 확보를 위해)

✓ **방역 및 소독 관련 주체는?**

- 학교 내 각 시설에 대한 방역과 소독 활동은 행정지원팀에서 총괄하되 세부적인 담당자의 지정은 학교장이 자율적으로 결정함.

✓ **휴교, 휴업 실시 원칙과 기준은?**

- **휴업 및 휴교의 실시 원칙**

휴업이나 휴교는 사회적 파급이 크며, 특히 학교 밖에서 학생들이 통제가 되지 않아 오히려 유행을 확산할 수 있음.
특히 불필요하게 휴업이나 휴교를 한 경우 학업 시수의 부족으로 인해 실제로 필요한 경우에 실시할 수 없게 되므로 신중히 결정하여야 함.

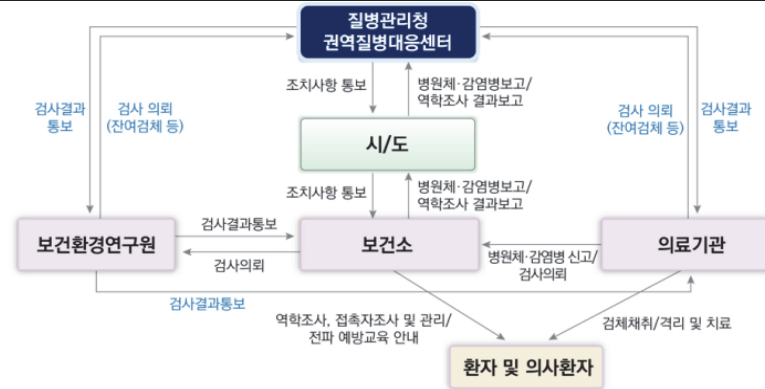
- 인플루엔자, 수두, 유행성이하선염, 수족구병, 유행성각결막염 등 학교에서 호발하는 대부분의 감염병에 대해서는 전파차단을 위한 휴업은 권장하지 않음.

- 유행이 확산된 학교의 학교장이 자체 휴업이 필요하다고 판단한 경우, 관할 보건소와의 협의를 거쳐서 휴업할 수 있음. 이 때 필요 시 「교육청 감염병 관리협의체」의 자문을 요청할 수 있음.

✓ **관내 학교에 대한 능동감시 실시기준 확인**

- 운영 : 평소 수동감시를 유지하다가, 관내 특정 학교에서 유행의심 상황(대응 제3단계) 발생 보고가 있는 경우 능동감시로 전환
- 실시기준 : 유행의심 상황(대응 제3단계)의 발생을 관내 학교로부터 보고받은 경우
- 실시방법 : 관내 학교들로부터 매일 환자 발생 현황을 보고받음.

✓ **감염병 발생 시 수행체계**



✓ 개별사례 역학조사 기준

- 합병증 또는 사망, 특수집단에서 발생한 사례에 한하며 시·군·구 역학조사반에서 실시

✓ 대응단계별 학교 내 감시체계 운영 및 교육(지원)청 보고방법

구분	발생학교의 유행단계	예방 단계	대응 제1단계	대응 제2단계	대응 제3단계		복구 단계
					「학교유행경보」 미발령	「학교유행경보」 발령	
환자 발생 학교	감시 방법	수동	수동	능동(해당 학급) 수동(기타 학급)	능동 (전체 학급)	능동 (전체 학급)	수동
	보고	-	-	환자발생 시	매일	매일	종료 시
환자 미발생 학교 (동일지역 내)	감시 방법	수동	수동	수동	수동	능동 (전체 학급)	수동
	보고	-	-	-	-	매일	-

1) 학교 내 수동감시 : 평소에 학생들을 관찰하거나 보건실 이용 과정을 통해 감염병 (의심)환자를 발견하는 것을 말함. p16 참조

2) 학교 내 능동감시 : 유행이 의심되는 일정 기간 동안 증상 유무 묻기, 검사 등을 통해 감염병 (의심)환자를 적극적으로 파악하는 것을 말함. p32 참조

✓ 대응 단계별 나이스(NEIS) 등록 담당

- 대응 제1,2단계 : 학교장의 재량에 따라 보건(담당)교사 또는 담임교사가 등록
- 대응 제3단계 : 담임교사가 실시하는 것을 권장함(유행 확산 시 환자수 증가로 인해 환자 등록과 보고가 지연될 수 있으므로 즉시성 확보를 위해)

✓ 출결 관리 및 수업 결손 구비서류

구 분	구비 서류
평상시	진료 확인서 ¹⁾ , 의사 소견서, 의사 진단서, 처방전 ²⁾ 중 1부
국가위기 상황	상기 서류 외 계산서나 영수증으로 대체 가능

1) 진료확인서는 학교 홈페이지에서 다운받아 활용할 수 있음. p138 참조

2) 진료확인서나 의사소견서 등을 제출하지 못하는 경우 처방전을 KOICD 질병분류센터 웹사이트에서 확인 후 인정 가능함.

✓ 수두 역학조사

- 대상

- 학교, 유치원, 영유아 보육시설, 군 부대·훈련소, 교정시설 등 집단시설에서 3주 이내 (의심)환자가 같은 시설에서 2명 이상 발생한 경우
 - * 단, 시설 전체 인원이 20명 미만인 경우 학급과 상관없이 최소 2명 이상 발생 시 실시
- (의심)환자가 2명 이상 역학적(시간적, 공간적으로 밀집)으로 연관된 경우
 - * 동거 가족 내에서만 한정되어 발생한 경우는 환자·접촉자 관리 조치만 실시

- 시기 : 신고 후 3일 이내

- 주관 : 시·군·구

✓ (보건소)유행 역학조사 내용

- 개별역학조사서 작성 및 보고
- 감염원, 감염경로 및 위험요인 파악
- 확진검사 실시를 위한 검체 채취 및 의뢰
- 유행 종료 후 역학조사 결과 보고서 작성 및 시·도에 보고

✓ 역학조사 시 절차: 역학조사관 협력 및 안내

- 역학조사관이 학교 발생 상황(노출 상황, 시설·환경 등)과 여건에 따라 위험도, 접촉자, 시설 등을 평가하고 관리·조치사항 등을 결정·안내
- 역학조사관의 안내에 따른 적극적인 협조 및 대응
- 보건소-학교(유치원) 합동 대응팀(핫라인) 구성: 단톡방 등
- 학부모(학생) 및 교직원 안내 문자 발송

✓ 역학조사 사전 준비자료 작성 및 제공

- 역학조사 사전준비 자료
 - 1) 교육기관 정보
 - 2) 직원 및 학생정보 환경정보
 - 3) 확진환자 정보
 - 4) 기관 내 확진자 접촉자 명단
 - 5) 확진환자 관련 준비 자료
 - 6) 기타
- 직원 및 학생 명부

		1) 교직원 명부(비상연락망) : 휴대폰 연락처 기재된 자료 제출, 겸임교사, 외부강사, 청소도우미, 발열체크 도우미, 시니어봉사단 등 학교 출입하는 모든 사람 포함하여 작성 2) 학생 명부 : 학반, 이름, 휴대폰 연락처, 주민등록번호(13자리), 현 주소를 엑셀자료로 작성하여 제출(파일로 제출 가능) - 학교 각종 배치도 1) 학교 시설배치도(층별 평면도 초함, 확진자 학반, 사용화장실 표시), 학급 내 학생 좌석배치도(출석일), 급식실 내 좌석배치도, 해당 기간 보건일지(환자 방문 확인) - 시간표 1) 해당 학반 시간표, 이동수업 시간표, 급식 시간표, 돌봄·방과후교실 시간표 등 해당 학생 동선에 포함되는 자료 제출 - 확진자 동선이 겹치는 학생 및 교직원 명단 1) 학생 : 학반, 이름, 휴대폰 연락처, 주민등록번호(13자리), 현 주소 기재하여 제출 - CCTV 확인 1) 고장 유무 및 작동 일자·시간 일치 여부 사전 확인 2) 역학조사 시 반드시 CCTV 조작(특정 시간대 및 화면 조작) 가능한 직원 1명 대기 - 기타 확인 1) 학원, 체육관 수강 여부 파악, 수강 시 학원명, 주소, (원장)연락처 확보 2) 동거인 현황 및 감염검사 유무 파악 3) 입원(예정)할 경우 병원명 확인
--	--	--

시나리오 단계 3-1 학교 유행경보발 령 (10분)	관내 학교에 대한 능동감시를 진행해 오던 S시 교육지원청은 철수의 누나 민희가 다니는 △△ 중학교와 철수와 미술학원을 같이 다니는 영호가 다니는 □□ 초등학교에서도 각각 3명과 7명씩 추가로 수두 확진 환자가 보고되었음을 확인하였다.	[시도교육청] 1) 지역 전문가나 보건소와 협의하여 학교유행경보 발령 및 교육부 보고 2) 방역당국과 학교유행경보 발령에 따른 유행 확산방지를 위한 연석회의 개최와 공동대응 실시 [교육지원청] 1) 학교유행경보 전파 2) 관내 학교에 대한 환자발생 확인 강화 [학교] 1) 감염병 미발생 학교라도 학교유행경보 발령 지역 학교는 수동감시를 능동감시로 전환, 보건교육과 가정통신문 발송 등 대응조치 실시 2) 해당학교에 대한 추가환자 파악 여부를 모니터링 해서 확산 여부를 파악하고, 필요 시 휴교나 각종행사 제한 등을 보건소 등과 협의하여 결정 3) 학교에서 등교중지 학생의 수업 결손에 대해서 교무부장이나, 담임교사의 역할이 있을 수 있으며, 등교중지 학생들의 생활지도 등도 필요 [보건소] 1) 해당 학교 외 지역사회(학원, 집단시설 등) 접촉자 명단 확보 2) 밀접 접촉자와 감수성자 분류 3) 관할 일선학교 및 교육청과 학교유행경보 발령에 따른 유행 확산방지를 위한 연석회의 개최와 공동대응 실시 ✓ 학교 유행경보 제도란? (목적) 관내 학교의 감염병 유행을 조기에 확인하고 대응 (대상) 산하 교육지원청과 동일 지역의 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 ✓ 학교 유행경보 발령기준은? (발령검토 기준) 관내 학교에 대한 능동감시 결과 최초 발생 학교를 포함하여 2개 이상 교육기관(유치원~고등학교까지 포함)에서 유행의심 상황이 확인된 경우 학교유행경보를 발령을 검토 ✓ 학교 유행경보 판단 및 발령 주체는?
---	---	--

		(판단 및 발령 주체) 교육청에서 필요성과 발령 범위를 판단하여 발령하되, 필요 시 교육청 감염병 관리 협의체 등의 자문을 받을 수 있음. (발령단위) 교육지원청 단위(동일 지역 초~고등학교를 포함). (참조사항) 학교유행경보를 발령하더라도 교육청 감염병 관리협의체 등의 판단에 따라 후속 조치를 달리할 수 있음. 예를 들어 인플루엔자 혹은 수족구병이 지속적으로 유행하는 경우 학교유행경보 발령이 학교현장에 상당한 부담을 야기할 수 있으므로 학교의 능동감시체계를 운영하지 않고, 학교의 자체적인 예방활동을 권고하는 수준으로 유행경보를 발령할 수 있음. 학교유행경보의 발령 범위를 결정할 때는 지역 특성을 고려하여야 함. 예를 들어 광역시의 경우 동일 생활권 학생들이 속한 다수의 교육지원청에 동시에 경보 발령 ✓ 교육청 감염병 전문가 위원회의 운영방안은? - 구성은 교육청 단위로 함 1) 학교/교육청 : 교육청 담당자 2) 보건당국 : 시도 보건과 담당자, 감염병관리본부 3) 민간전문가 : 소아청소년과/감염내과/예방의학(역학)/교육/상담/홍보 등 ○ 위원회를 교육청 단위 학생감염병 예방 종합대책 수립 시 포함시킴. ○ 교육청 단위 감염병 예방·관리 계획 수립에 대한 자문과 지역 내 유행발생 학교에 대한 기술자문 지원 (역학조사, 휴업/휴교 결정 등)
시나리오 단계 4 감염병 유행 종결 (10분)	지속적인 모니터링을 해오던 ○○초등학교 담임교사 및 보건교사는 4월 3일 이후 4월 24일 현재까지 더 이상의 추가 환자 발생은 없음을 확인하였다.	[담임교사] 수두 유행 종료에 대한 가정통신문 발송, 수업결손 지원 [보건(담당)교사] 발생 현황 및 조치사항을 정리하여 학교장과 교육(지원)청에 보고 [행정실] 2학년 3반과 같은 층에 모든 공간, 의심환자 발생 공간, 보건실 및 휴게실(일시적 관찰실)의 환기 및 소독 종료 [교장 및 교감] 학생감염병관리조직의 유행 대응활동을 중단하고 예방단계로 복귀 [교육청]

		1) 필요 시 감염병 학생 대상 심리상담 실시할 수 있도록 행정 지원 2) 능동감시 및 학교유행경보 해제를 판단해서 조치 [보건소] 1) 수두의 잠복기(10-21일)를 고려하여 4월 3일 이후부터 추가 발생자의 잠복기 4월 24일까지 더 이상의 추가 환자가 없으므로 모니터링 종료 및 유행 종료를 확인시켜 줌 2) 감염병 유행에 대한 예방 및 후속조치, 교육 실시 ✓ 학생 감염병 유행종료 기준은? - 학교 내에서 해당 감염병 환자가 모두 완치되고, 최대 잠복기까지 (의심)환자 추가 발생이 없는 경우 유행 종료 - 방역당국에서 역학조사를 실시한 경우 방역당국의 판단에 따름 - 수두 잠복기(10-21일, 평균 14-16일)
훈련 정리 (5분)		✓ 훈련생들이 감염병 대응 훈련을 하면서 역할별로 현실 상황과 맞지 않는 부분, 혹은 아쉬운 부분, 느낀 점 등을 자유롭게 이야기 하도록 함 ✓ 모더레이터가 훈련생들의 대응을 지켜보면서 느낀 점, 개선점, 잘 된 점 등을 정리

감염병 관리 서서

다들 물어봐

김여병 관리대장

(20) 五五

OO초/중/고등학교 보견실

[illegible]

감염병 환자 발생 현황

감염병 환자 발생 현황

(20)

결 계	교사	부장	교감	교장
	〈전결〉			

내 용	학년/반	성명	건강 상태 및 치료 상황		
1. () 확진으로 결 석 자	예) 1-2	홍길동	입원, 통원치료, 자택격리		
2. () 의심으로 결 석 자					
3. () 의심으로 진료의뢰자 및 조 퇴 자	학년/반	성명	건강상태	병원진단결과	상담 및 지도내용
				예) 정상	
4. 보건교육	예) 가정통신문, 학급/복도 게시물, 유인물 배부, 학교홈페이지 탑재				
5. 보고/신고	예) 나이스(NEIS) 감염병 환자관리 등록·보고 보건소 신고(신고방식에 '○' 표시 : 나이스, 전자문서, 팩스, 전화 등) (신고 받은 담당자 이름 : 전화 : 시간 :)				

법정감염병 보건소 신고 양식

학교 감염병 환자 신고

수신 : ○○보건소장

[감염병의 예방 및 관리에 관한 법률] 제12조에 따라 학교에서 인지된 감염병(의심) 발생 현황을 다음과 같이 알려드립니다.

이름	학년	반	감염병명	발생인지일	비고

※ 학생의 개인정보에 대한 사항은 추후 전화를 통하여 확인하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

○ ○ 학 교 장

등교중지 원칙 및 절차

「학생 감염병 예방·위기 대응 매뉴얼」 p98~99 요약

- ▶ 등교중지가 필요한 감염병이 의심되는 경우 확인을 확인할 때까지 등교중지
- ▶ 등교중지가 필요한 감염병으로 확진되는 경우, 격리기간 동안 등교중지(격리 기간은 원칙적으로 의사소견을 따름)
- ▶ 등교중지 학생이 확진일 경우, 관련법령에 따라 출석처리 하고, 진료결과 감염병이 아니었다 해도 확인기간까지는 출석으로 인정
- ▶ 담당교사-보호자의 연락을 통해 진료결과 확인
 - 등교 중지 기간을 확인할 수 있는 경우에는 해당 기간 동안 등교 중지를 실시함.
 - 등교 중지 기간은 확인할 수 없지만 질환명(의심 포함)을 확인할 수 있는 경우 보건(담당)교사가 최초 증상 일을 기준으로 해당 감염병의 「전파 차단」을 위한 등교 중지 기간을 적용함



참고사항

등교 중지 필요 감염병은 제2장 III. 2. 「감염병별 역학적 특성과 관리 방안」 참조

매뉴얼
p67 참조

- ▶ 감염병이 의심되어 의료기관 진료를 의뢰할 때 보호자에게 진료확인서와 등교중지 안내서 배부
 - ※ 등교하지 않고 병원에 가는 경우, 홈페이지에서 다운받을 수 있도록 학부모(학생)에게 안내(병원에서 참고할 수 있도록 제시)
- ▶ 담당교사는 가정에서의 유의사항(가정 내 격리, 학원 등원 중지 등)을 반드시 안내

등교 중지자 자가 격리 시 준수사항

- 원칙 : 독립된 공간에서 혼자 생활토록 하며, 가족 간 밀접 접촉을 최소화(마스크 착용 등)
- 준수사항(예시)
 - 환기가 잘되는 곳에서 생활하며 창문을 열어 자주 환기시킴.
 - 식사는 혼자서 하고, 화장실과 세면대가 두 개 이상인 경우 하나를 혼자 사용함.
 - 화장실과 세면대를 다른 사람과 같이 사용하는 경우 다른 사람이 사용하기 전에 소독을 해야 함.
 - 다른 사람과 접촉을 하지 않으며 불가피한 경우 서로 마스크를 쓰고 2m 이상의 거리를 유지함.
 - 수건, 식기류, 휴대전화 등 생활용품은 단독으로 사용함. 의복 및 침구류도 별도 사용 및 세탁.
 - 손은 비누를 이용하여 30초 이상 씻고, 입은 항상 가리고 기침하는 등 개인위생을 철저히 함.
 - 기침을 할 때는 휴지로 입과 코를 막으며, 사용한 휴지는 반드시 뚜껑이 달린 휴지통에 버림.
 - 학원 및 다중이용시설, 사람이 많은 곳 방문을 자제함.

- ▶ 등교 중지 종료 시점 이후에도 감염병 증상이 남아있는 경우 진료확인서나 소견서 등을 제시하면 등교 중지 기간을 연장할 수 있음
- ▶ 등교 재개 시 진료확인서, 의사소견서, 진단서 제출 권장(부득이한 경우 처방전 인정)

등교 중지 기간 출석 인정 기간문

등교 중지 기간 출석 인정 기간문

○○○ 학교

수신 내부결재
(경유)
제목 감염성 질환으로 인한 등교 중지 및 출석인정

「학교보건법」 제8조 및 동법 시행령 제22조에 의거 다음과 같이 등교 중지 기간을 출석으로 인정하고자 합니다.

대 상 자	O학년 0반 0번 홍길동
질 병 명	수두
발생 인지일	20
등교 중지 기간 (출석인정 기간)	20 ~ 20 (일간)
등 교 일	20
제출 서류	진료 확인서(또는 의사 소견서나 의사 진단서)
나이스(NEIS) 출결 입력	메르스로 인한 등교 중지

* 참고 : 교육부 훈령 제393호, 학교생활기록 작성 및 관리지침 별표8 제2항

○○○ 학교장

교사	부장교사	교감	교장
협조자			
시행	○○학교-	(20 . . .)	접수 (20 . . .)
우	000-0000 (주 소)		/ http://www.000.00.kr
전화	000-0000	전송 000-0000 / 이메일	/ 공개구분

등교 중지 안내서와 진료확인서

(앞면)

등교 중지 안내서

학년 반 번 이름 : _____

안녕하세요? 가정에 건강과 행복이 함께 하길 기원합니다.
위 학생은 감염병(수두)에 감염되었거나 의심되어 다른 학생의 감염을 예방하기 위하여 등교중지를 권고하오니, 뒷면 진료확인서에서 의사가 적시한 기간동안 등교중지 시키고 아래의 가정에서 지켜야 할 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

등교 중지 기간동안 가정에서 지켜야 할 사항

1. 자녀가 감염병이 의심될 경우, 마스크를 착용하고 가까운 의료기관 방문합니다.
 2. 원치될 때까지 가정 또는 병의원에서 격리치료를 받습니다.
 3. 원치되어 전염성이 소실될 때까지, 학교 및 학교 밖 교육시설(학원, 교습소, 개인피외 등), 다중이용시설(도서관, PC방) 방문을 자제하여 타 학생 감염되지 않도록 가정 내 생활지도를 철저히 하여야 합니다.
 4. 가족 간에도 감염 우려가 있으므로 가정 내에서도 독립된 공간에서 생활하여 가족과의 접촉을 제한하고, 수건을 따로 사용하는 등 위생관리를 철저히 합니다.
 5. 보건소 및 의료기관의 등교중지 권고 기간이 지나고, 증상이 완쾌한후 등교합니다.
 6. 완쾌 후 등교할 때는 선생님께서 진료 확인서, 의사소견서, 진단서, 처방전 중 1부를 제출하여 주시기 바랍니다.
- ※ 등교 중지 기간까지 완치되지 않은 경우 전염력이 없다는 의사의 진단일까지 기간을 연장합니다.
※ 감염병으로 인한 등교 중지 기간은 출석으로 인정됩니다.

<관계법령>

- ◆ 「학교보건법」 제8조, 동법 시행령 제22조
- ◆ 「초·중등교육법」 제64조, 동법 시행령 제47조
- ◆ 교육부훈령 제393호 「학교생활기록 작성 및 관리 지침」 제8조 제2항
- ◆ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조

20 . . .

○○ 학교장

진료 확인서(예)

안녕하십니까? 항상 본교 학생들의 질병관리에 힘써주심에 감사드립니다.

본교에서는 「학교보건법」 제8조 및 동법 시행령 제22조에 의거 법정감염병 또는 감염성이 강하여 학교 내 단
체생활에 피해가 우려되는 질병에 대하여 병원의 소견서를 근거로 등교 중지를 통해 가정에서 요양하
도록 하고 있습니다.

등교 중지 대상자 선별을 위해서 의사선생님의 진단과 소견을 참고하고자 하오니 아래의 내용을 참고 하시기
적어 보내주시면 대단히 감사하겠습니다.

학년 반 번 이름 : _____

1. 진단(의심) 질환명 :

2. 발 병 일 :

3. 소견내용 :

위 환자는 상기질환으로 약 월 일부터 월 일까지의 (통원, 입원)치료를 요하나, 증상의 호
전정도에 따라 그 기간의 중검이 필요하고, 추후 위 질환과 관련된 합병증의 관찰과 계속적인 주의를 요합니다.

※ 참고자료 : 학교 빈발 감염병별 권장 등교 중지 기간

학교 빈발 감염병	권장 등교 중지 기간
급성 출혈성 결막염	격리없이 개인위생수칙을 지킬 것을 권장함
수두	모든 수포에 가피가 형성될 때 까지
수족구병	수포 발생 후 6일간 또는 가피가 형성될 때 까지
유행성각결막염	격리없이 개인위생수칙을 지킬 것을 권장함
유행성이하선염	증상 발현 후 5일까지
인플루엔자	증상 발현 후 5일 경과하고 해열제 없이 체온회복 후 48시간 까지
노로바이러스	구토, 설사 등 증상이 없어진 후 2일까지

발 행 일 : 20 . . .

병 원 명 :

의 사 명 :

(인)

(※고무인 유효함)

○○○학 교 장

수두 유형에 따른 가정통신문(예시)

학부모님, 안녕하십니까? 닥 내 평안과 건강을 기원합니다.
최근 OO 초등학교에서 수두 환자가 발생하였습니다. 수두는 전염력이 매우 높은 감염병으로 각 별한 관리가 요구되고 있습니다. 이에 따라 유행의 가능성이 있는 수두의 예방관리에 대해 안내해 드리고자 하오니 가정에서는 감염병 예방관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 수두

병원체	▪ 수두-대상포진 바이러스(Human alphaherpesvirus 3) - 피부 병변에 전염력이 있는 수두-대상포진 바이러스가 존재
전파경로	▪ 수두 환자의 수포액과 직접 접촉(피부 병변이 주요 감염 전파원) ▪ 수두 환자의 호흡기 분비물을 에어로졸로 흡입 ▪ 금성 수두 또는 대상포진 환자의 피부병변 수포액을 에어로졸로 흡입
증상 및 임상경과	▪ 감수성 있는 사람이 감염되면 거의 대부분 발진이 나타남(무증상 감염은 드물) ▪ 선천성 수두 - 임신 첫 20주 이내 임부의 원발성 수두 감염은 선천성수두증후군(사지형성부전, 피부반흔, 국소 근위축, 뇌염, 피질위축, 맥락망막염, 소두증, 저체중 등 신생아 기형)과 관련 있음 (기형 위험은 2% 미만) ▪ 후천성 수두 - 전구기 : 발진 시작 1~2일 전부터 열감, 권태감이 나타남(소아는 발진이 첫 증상인 경우가 많음) - 발진기 : 발진은 보통 두피, 얼굴, 또는 몸통에 먼저 나타나고 사지로 퍼지는 양상이며, 수두 백신 미접종자는 발진이 전신화되고 가려움증이 있으며 반점(macules), 구진(papules), 수포(vesicles), 농포(pustules), 가피(crust) 순으로 병변이 24시간 이내에 빠르게 진행됨 - 회복기 : 모든 병변에 가피가 형성되면서 회복함  [수두 증상]
치료	▪ 합병증 없는 경우 대증치료, 중증화 위험이 있는 경우 항바이러스제로 치료
유행양상	▪ 수두는 피부병변과의 접촉 또는 말하거나 재채기할 때 나오는 호흡기 분비물을 통해 감염되므로, 집단생활을 하는 학교 등에서 발생 경우가 우려됨
환자관리	▪ 전파방지를 위해 환자는 모든 병변이 가피로 앓을 때까지 격리가 필요함
예방	▪ 소아: 생후 12~15개월에 수두 백신 1회 접종(만 13세 이상 미접종자는 4~8주 간격 2회 접종) ▪ 성인: 4~8주 간격 2회 접종

2. 예방수칙

단체 생활 감염병 예방수칙

✓ 첫째, 비누를 사용하여 30초 이상 손을 자주 씻고, 기침이나 재채기를 할 때는 손이 아닌 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 기침예절을 지켜 주십시오.

✓ 둘째, 감염병 의심증상이 발생한 경우 다른 사람과 접촉하지 않고 곧바로 가까운 의료기관에서 진료를 받으십시오.

✓ 셋째, 집단유행을 막기 위해 감염 환자는 전염기간* 동안에는 등원·등교(학원 등 사람이 많은 장소 포함)를 하지 않도록 하십시오.

* 등원·등교중지 기간

수두: 모든 피부병변에 딱지가 앉을 때까지 격리

❖ 가정에서 지켜야 할 일

구 분	활	동
▪ 발진, 식욕부진 등 수두전신증상 확인 시	▪ 학교 등교 전 담임 선생님께 연락 후 가까운 병의원 진료 실시 ▪ 모든 피부병변의 가피(딱지)가 생길 때까지 환부 자극 피함	
▪ 수두 환자와 접촉 시	▪ 마스크를 착용하고 접촉 후 3~5일 이내 예방접종을 권장하며, 개인위생 철저준수하고 의심증상이 나타나면 즉시 병의원을 방문하여 진료 받도록 권장	
▪ 병원에서 수두 확진 시	▪ 담임 선생님께 진단 사실을 알리고, 의사의 판단에 따라 입원 또는 집에서 치료 실시 및 물품 별도 사용 ▪ 진료확인서에 기록된 격리기간 동안 등교 중지 및 사람들이 많은 장소에 가지 않도록 함	

수두 Q&A

Q1. 수두와 대상포진은 어떤 관계가 있나요?

A. 수두와 대상포진은 같은 바이러스에 의한 질환입니다. 수두-대상포진 바이러스에 처음으로 감염되면 수두로 발병하며 바이러스는 평생 몸 안에 존재하게 됩니다. 회복 후 바이러스가 감각신경절에 잠복해 있다가 재발하면 대상포진이 발병할 수 있습니다. 수두에 걸렸던 사람의 30%는 대상포진이 나타날 수 있고, 대부분 50세 이상의 연령에서 발병하며 나이가 많을수록 빈도가 증가합니다. 소아의 대상포진 발생 빈도는 성인에 비해 매우 낮으며 대상포진 후 통증도 거의 없습니다.

Q2. 아이가 어린이집에서 수두가 의심되는 아이에게 노출 되었다고 생각이 든다면 어떻게 해야 하나요?

A. 아이가 과거에 수두를 앓았거나 예방접종을 받았다면 특별한 조치는 없으나, 의심되는 환자와 마지막 접촉일(노출일)로부터 21일 동안 증상(발열, 발진 등)이 나타나는지 모니터링 합니다. 과거에 수두를 앓은 적이 없거나 수두 예방접종을 받지 않았다면 노출 후 가능한 한 빨리 예방접종을 실시하도록 합니다. 노출 후 3일 내(5일 이내까지 가능)에 예방접종을 받으면 질병의 예방과중한 경과를 막을 수 있다는 연구 결과가 있으며, 감염되지 않은 사람도 미래의 질병을 예방할 수 있습니다.

Q3. 대상포진이 의심되거나 진단될 경우 보건소로 신고해야 하나요?

A. 대상포진은 발생신고가 의무인 법정감염병은 아닙니다